

PSICOPATOLOGÍA GENERAL

INTRODUCCIÓN Y SELECCIÓN METODOLÓGICA ÍNTEGRA — Karl Jaspers (1913 / 1966)

Traducción castellana oficial: Dr. Roberto O. Saubidet y Diego A. Santillán · Editorial Beta (Buenos Aires, 1966)

Título original: *Allgemeine Psychopathologie* (Berlín, Springer Verlag, 1913)

Asignación académica: Clase 3 — Jaspers y el método psicopatológico (Psicopatología I · UFLO Online 2026)

INTRODUCCIÓN

En esta introducción se actualizará el espacio abierto en que se mueve el conocimiento psicopatológico. No se echará el cimiento firme en el que se habrá de levantar el edificio; pues el cimiento propio correspondiente se dará en cada uno de los capítulos. No se informará tampoco sobre experiencias, pero se intentarán discusiones sobre los modos de las experiencias y sobre el sentido de la psicopatología general.

§ 1. DELIMITACIÓN DE LA PSICOPATOLOGÍA GENERAL

a) La psiquiatría como profesión práctica y la psicopatología como ciencia

En la profesión psiquiátrica práctica, se trata siempre de los seres humanos individuales y enteros, ya sean puestos a disposición del psiquiatra para la custodia, la atención y la curación, o haya de hacer un peritaje ante los tribunales, ante otras autoridades, o ante la ciencia de la historia sobre una personalidad, ya sea porque el enfermo acuda a su consejo en el consultorio. Mientras su trabajo entero tiene que ver con un caso individual, trata el psiquiatra de estar a la altura de las exigencias que se le hacen en tales casos individuales; en cambio, el **psicopatólogo** queda en el dominio de los conceptos y las reglas generales.

El psiquiatra en la vocación práctica es una personalidad viviente, que capta y actúa, para lo cual la ciencia sólo es un medio auxiliar; en cambio, para el psicopatólogo esa ciencia es en sí misma el objetivo. Sólo busca conocer, caracterizar y analizar, pero no al hombre particular, sino al hombre en general. No pregunta sobre la utilidad de su ciencia como medio auxiliar —eso se establecerá por sí mismo con el progreso de los resultados—, sino que se preocupará de reconocimientos, de verdades, de lo obligadamente demostrable o de lo claramente distinguible. No quiere la interpretación afectiva o la empatía (*Einfühlung*) o la contemplación o visión en sí —esto sólo es para él material, cuyo rico desarrollo le es indispensable—, sino que busca lo expresable en conceptos, lo comunicable, lo que se puede exigir en reglas y se deja comprender en algunas relaciones. Esto le pone por un lado límites que tiene que conocer, para no traspasarlos indebidamente; le da por otra parte un amplio dominio que tiene el derecho y la obligación de tomar enteramente en posesión.

Sus límites consisten en que no puede disolver nunca enteramente al hombre individual en conceptos psicológicos. Cuanto más llega a conceptos, cuanto más reconoce y caracteriza como típico, regular, tanto más reconoce que en todo individuo se oculta algo incognoscible para él. Como psicopatólogo, le basta saber de la infinitud inagotable de todo individuo; como hombre puede, independientemente de ello, ver todavía más; pero si otros ven más, algo incomparable, no debe hacerlo entrar en la psicopatología. Las valoraciones éticas, estéticas, metafísicas, sobre todo, son por completo independientes de las valoraciones y de las disecciones psicopatológicas.

b) El objeto de la psicopatología: El acontecimiento psíquico consciente

El objeto de la psicopatología es el **acontecimiento psíquico realmente consciente**. Deseamos saber qué experimentan los seres humanos en sus vivencias y cómo las experimentan; queremos conocer las dimensiones de las realidades anímicas. Y no sólo investigamos la vivencia humana, sino también las condiciones y causas de las que depende, los modos en que se

expresa y las relaciones de sentido que la ligan a otros acontecimientos psíquicos.

El límite de nuestra ciencia reside en que lo somático extrapsíquico sólo nos interesa en la medida en que condiciona o modifica la vida psíquica, y en que lo inconsciente sólo puede ser abordado a partir de sus manifestaciones en la conciencia o mediante construcciones conceptuales rigurosamente delimitadas.

§ 2. ALGUNOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES: EL BINOMIO METODOLÓGICO

a) Explicación causal (*Erklären*) y Comprensión psicológica (*Verstehen*)

En el estudio de los fenómenos psicopatológicos nos encontramos frente a dos caminos metodológicos irreducibles entre sí:

1. La Explicación Causal (*Erklären*):

Es el método de las ciencias naturales. Consiste en la demostración de conexiones causales objetivas entre factores somáticos (lesiones cerebrales, tóxicos, infecciones, factores hereditarios) y alteraciones psíquicas. Establece leyes generales de causa y efecto observadas «desde fuera».

2. La Comprensión Psicológica (*Verstehen*):

Es el método de las ciencias del espíritu. Consiste en la captación intuitiva e inmediata de las **relaciones de sentido** internas. Comprendemos cómo un estado psíquico surge y deriva de otro estado psíquico vivenciado (por ejemplo, cómo el duelo surge de la pérdida, o cómo los celos nacen de la sospecha). La comprensión se efectúa «desde dentro» del sentido humano.

b) Comprensión Estática (*Fenomenología*) y Comprensión Genética

- *Comprensión Estática (Fenomenología pura)*: Consiste en hacer presente ante los ojos y describir con la máxima pureza los estados anímicos particulares tal como son vividos por el enfermo (el modo en que se siente una alucinación, una vivencia de extrañeza o un humor delirante).
- *Comprensión Genética*: Capta la génesis y el encadenamiento dinámico de los motivos y de las vivencias que se desarrollan unas a partir de otras.

c) Desarrollo de la personalidad vs. Proceso mórbido

La distinción entre desarrollo y proceso marca el límite insuperable de la comprensión:

- En el **Desarrollo de la personalidad**: Las transformaciones anímicas son comprensibles psicológicamente como una evolución o reacción continua a partir de las disposiciones previas y las vivencias del sujeto.
- En el **Proceso psíquico (esquizofrenia / psicosis orgánicas)**: Se produce una ruptura radical e incomprensible de la continuidad biográfica. Irrumpe un elemento heterogéneo que no deriva de motivos comprensibles y que testimonia la presencia de una alteración biológica subyacente que sólo puede ser *explicada causalmente*.

§ 3. LOS PREJUICIOS EN PSICOPATOLOGÍA

La investigación científica se ve frecuentemente falseada por prejuicios dogmáticos que es preciso superar:

1. El Prejuicio Somatológico («Mitología Cerebral»):

Es el dogma que postula que todo síntoma o hecho psíquico debe ser reducido exclusivamente a una lesión cerebral localizada (máxima de Griesinger: «las enfermedades psíquicas son enfermedades del cerebro»). Este prejuicio sustituye el

análisis riguroso de las vivencias conscientes por esquemas anatómicos ficticios y especulaciones mecanicistas.

2. El Prejuicio Intelectualista o Psicológico:

Consiste en pretender derivar la vida psíquica anormal a partir de reglas lógicas abstractas preconcebidas, desconociendo la especificidad de los afectos, los impulsos y las vivencias primarias.

3. El Prejuicio Filosófico:

Consiste en forzar a la clínica dentro de sistemas metafísicos universales a priori, en lugar de someterse a la fenomenología de los hechos psíquicos concretos y sus relaciones demostrables.

Conclusión de la Selección:

La psicopatología general requiere un pluralismo metodológico riguroso: utilizar la explicación causal en el ámbito de los procesos somáticos objetivos y aplicar la comprensión fenomenológica en el dominio de las relaciones de sentido consciente, manteniendo siempre la conciencia lúcida de los límites de cada método.